

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Pediátrica —

PACIENTE

Tomás Ignacio Restrepo Vargas

DOCUMENTO

TI 1121000099

FECHA NACIMIENTO

18/04/2013

EDAD

13 años, 8 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

4° Primaria

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

14/01/2027

ORDEN N°

—

PROTOCOLO APLICADO

bateria_completa_infantil

ELABORADO POR

Profesional admin-read

Psicólogo

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	Tomás Ignacio Restrepo Vargas	Lateralidad:	Diestro
Documento:	TI 1121000099	Ocupación:	Estudiante
Fecha de nacimiento:	18/04/2013	Ciudad:	Pereira
Edad:	13 años, 8 meses	Acompañante:	Madre Lucía Vargas
Sexo:	Masculino	Remite:	Colegio + familia
Escolaridad:	4° Primaria	EPS / Asegurador:	Sura EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Madre y colegio reportan dificultades severas en matemáticas desde 1° grado. Lectura y escritura en rango normal-bajo. Conducta desatenta en clase. Evaluado previamente (WISC-IV en 2024) con perfil irregular. Solicita actualización completa.

HISTORIA DEL DESARROLLO

Hitos relevantes en la trayectoria evolutiva

Perinatales y prenatales

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Trayectoria escolar

Estudios: 4° Primaria. Ocupación: Estudiante.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: bateria_completa_infantil

Prueba	Dominio	Dur.
Diseño con Cubos	Razonamiento Perceptual	—
Semejanzas	Comprensión Verbal	—
Vocabulario	Comprensión Verbal	—
Números y Letras	Memoria de Trabajo	—
Claves	Velocidad de Proceso	—
Aritmética	Memoria de Trabajo	—
Ind Comp Verb	Índice CI	—
Ind Raz Perce	Índice CI	—
Ind Mem Trab	Índice CI	—
Ind Vel Proce	Índice CI	—
CI total	Inteligencia General	—
PAS Total	Socioemocional - Ansiedad	—
CDI Escala de depresión	Socioemocional - Depresión	—
Interacción Social	Socioemocional - TEA	—
Patrones Restringidos de Conducta	Socioemocional - TEA	—
Patrones Cognitivos	Socioemocional - TEA	—
Habilidades Pragmáticas	Socioemocional - TEA	—
Coeeficiente de Trastorno de Asperger	Socioemocional - TEA	—
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—

ANTECEDENTES

Patológicos/ Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Sin antecedentes psiquiátricos previos.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Niega TEC previo.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica. Paciente colaborador.

Atención y concentración

Atención sostenida снижена. Span atencional de 4-5 minutos. Errores por descuido en tareas de cálculo. Necesita re-dirección externa frecuente.

Memoria

Memoria de trabajo auditiva dentro de lo esperado. Memoria visual снижена percentil 25-50. Curva de aprendizaje verbal plana (3 palabras en 3 ensayos).

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje comprensivo y expresivo en percentil 50-75. Vocabulario en percentil 90. Comprensión de instrucciones complejas preservada.

Funciones ejecutivas

Funciones ejecutivas heterogéneas. Planeación preservada. Flexibilidad снижена (categorías WCST 4/6). Inhibición en percentil 25. Velocidad de procesamiento снижена percentil 16.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo: F81.2 - Trastorno del cálculo + comorbilidad atencional

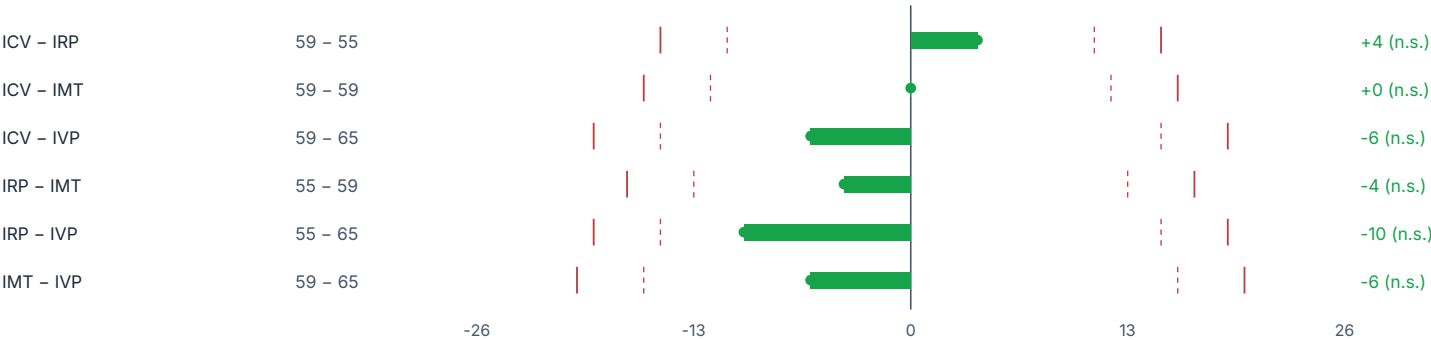
RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes estandarizados y perfil cognitivo

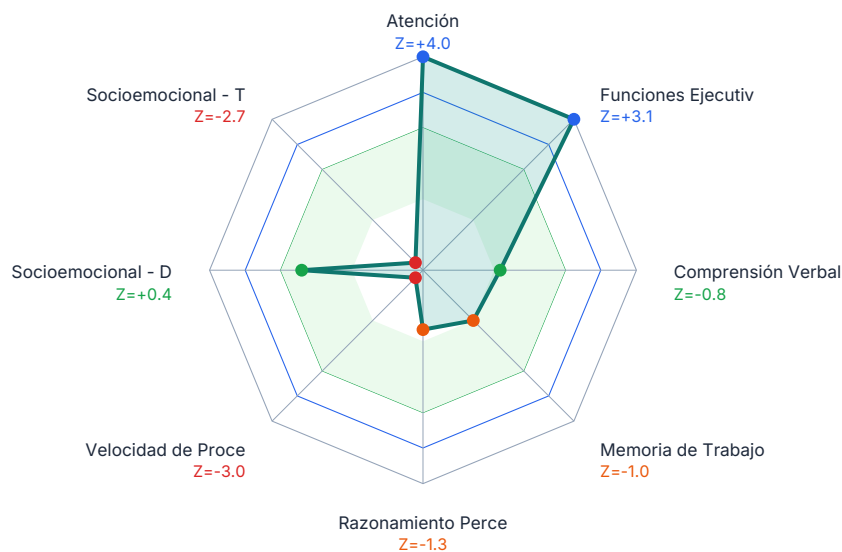
Comp Verb	Raz Perce	Mem Trab	Vel Proce	CI total
59	55	59	65	50
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Discrepancias entre índices

Diferencia = valor del primer índice – segundo. Líneas críticas según Wechsler ($p<.15$... y $p<.05$).

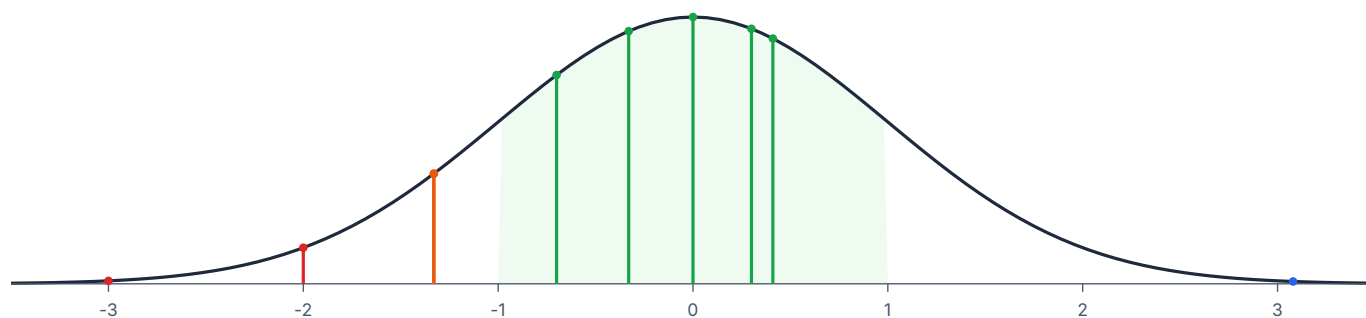


Perfil cognitivo por dominio



Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 14 pruebas con norma disponible



Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
Diseño con Cubos							-1.33
Semejanzas							-0.33
Vocabulario							-1.33
Números y Letras							+0.00
Claves							-3.00
Aritmética							-2.00
Ind Comp Verb							-2.73
Ind Raz Perce							-3.00
Ind Mem Trab							-2.73
Ind Vel Proce							-2.33
CI total							-3.33
CDI Escala de depresión							+0.41
Interacción Social							+0.30
Patrones Restringidos de Conduct							-4.10
Patrones Cognitivos							-4.60
Habilidades Pragmáticas							-4.50
Coefficiente de Trastorno de Aspe							-0.70
TMT A							+4.00
TMT B							+3.08

Banda verde = rango normal (-1 a +1 σ). Z < -1 sugiere debilidad. Z > +1 sugiere fortaleza relativa.

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
Diseño con Cubos	28	6	-1.33	Limítrofe
Semejanzas	24	9	-0.33	Promedio
Vocabulario	30	6	-1.33	Limítrofe
Números y Letras	18	10	+0.00	Promedio
Claves	26	1	-3.00	Bajo
Aritmética	14	4	-2.00	Bajo
Ind Comp Verb	9	59	-2.73	Bajo
Ind Raz Perce	8	55	-3.00	Bajo
Ind Mem Trab	6	59	-2.73	Bajo
Ind Vel Proce	7	65	-2.33	Bajo
CI total	30	50	-3.33	Bajo
PAS Total	60	—	—	Sin dato
CDI Escala de depresión	14	0	+0.41	Promedio
Interacción Social	12	53	+0.30	Promedio
Patrones Restringidos de Conducta	14	9	-4.10	Bajo
Patrones Cognitivos	6	4	-4.60	Bajo
Habilidades Pragmáticas	8	5	-4.50	Bajo
Coefficiente de Trastorno de Asperg	6	43	-0.70	Promedio
TMT A	50	4	+4.00	Superior
TMT B	90	3	+3.08	Superior

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

Tomás obtuvo un Cociente Intelectual Total (CIT) de 50, ubicándose en la categoría extremadamente bajo (percentil aproximado 0). Los índices compuestos muestran homogeneidad relativa (rango IRP=55 a IVP=65), lo que respalda la interpretación del CIT como medida representativa.

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: velocidad de proceso (severamente disminuido, $Z=-3.0$); socioemocional - tea (severamente disminuido, $Z=-2.7$); razonamiento perceptual (moderadamente disminuido, $Z=-1.3$); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, $Z=-1.0$). Por su parte, destacan como áreas preservadas o por encima del promedio: atención (muy alto, $Z=+4.0$); funciones ejecutivas (muy alto, $Z=+3.1$).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Patrones Cognitivos ($Z=-4.60$, bajo); Habilidades Pragmáticas ($Z=-4.50$, bajo); Patrones Restringidos de Conducta ($Z=-4.10$, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño preservado / superior

- Patrones Cognitivos — bajo ($Z=-4.60$)
 - Habilidades Pragmáticas — bajo ($Z=-4.50$)
 - Patrones Restringidos de Conducta — bajo ($Z=-4.10$)
 - Claves — bajo ($Z=-3.00$)
 - Aritmética — bajo ($Z=-2.00$)
 - Diseño con Cubos — limítrofe ($Z=-1.33$)
- TMT A — superior ($Z=+4.00$)
 - TMT B — superior ($Z=+3.08$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó Tomás. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En NiWiscSem, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiWiscLN, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. En NiCDI, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En NiWiscAri, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo. En NiWISCIndComVer, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En NiWiscSem, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscLN, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiCDI, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiGadsIS, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiGADSCTAs, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En NiWiscCI, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En NiWiscAri, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En NiWISCIndComVer, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En NiWISCIndRazPer, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.
- En NiWISCIndMemTra, tu rendimiento fue por debajo del promedio. Esto se puede trabajar con práctica y apoyo.

¿Qué recomendamos?

Recomendación: ADAPTACIONES CURRICULARES: tiempo extendido en evaluaciones (1.5x), calculadora autorisée, problemas contextualizados en lugar de abstractos, evitar dictado de números. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). En el colegio/academia: puede ser útil hablar con tus profesores para explorar apoyos como tiempo extra en exámenes o actividades adaptadas. Recomendación: Psicoeducación a docentes sobre discalculia y comorbilidad atencional. Evitar etiquetas de 'flojo' o 'poco inteligente'. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos). Recomendación: Apoyo parental en tareas: priorizar comprensión sobre velocidad, evitar castigo por errores en aritmética, celebrar logros en otras áreas. (consulta con tu psicólogo/a para detalles específicos).

Preguntas frecuentes

- ¿Mis resultados son permanentes?
No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica y los apoyos adecuados. Los resultados que obtuviste son una foto del momento actual.
- ¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?
Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto no significa que haya algo mal en ti.
- ¿Necesito otro tipo de evaluaciones?
Tu psicólogo/a te dirá si se necesitan otros estudios (por ejemplo, evaluación pedagógica, médica, o del lenguaje). No te preocupes si no entiendes algún término: puedes preguntar siempre.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F81

Impresión diagnóstica: F81.2 - Trastorno del cálculo + comorbilidad atencional